

妊娠高血圧症候群
胎児発育遅延
妊娠中の薬、母子保健

2026年7月6日(月)第2限

産科婦人科 北折 珠央

妊娠高血圧症候群の歴史

- ・紀元前2200年

「分娩の日には婦人が舌を嚙まぬよう木片を嚙ませる」

と子癇に対する予防処置と推測される記載があるパピルスがエジプトの都市から出土

- ・18～19世紀に血圧や尿蛋白が測定できるようになると子癇を発症した妊婦で高血圧や蛋白尿が見られることがわかった

- ・日本では1952年頃、「**妊娠中毒症**」という概念ができた

- ・2004年に「**妊娠高血圧症候群**pregnancy induced hypertension(**PIH**)」

2017年 妊娠高血圧症候群 **hypertension disorder of pregnancy (HDP)**に改変

ある妊娠高血圧症候群症例

41歳で今回**体外受精**でようやく妊娠でき近くのクリニックで健診を受けていました。これまで特に病気はしたことはありません。**父は高血圧**があるそうです。妊娠30週の定期健診で血圧が130台で少し高めでしたが他に問題はなさそうでした。次の32週の健診で**血圧が140をこえて尿検査で蛋白**がでており、1週間後に受診するように言われました。33週で受診したとき血圧も尿蛋白も悪化しているので大きい病院にいくようにいわれ、周産期センターのある大学病院を紹介され受診したところそのまま入院することになり驚き、不安も感じました。

入院したころから頭が重い感じがあり、**足もむくんで**いました。超音波の検査で**赤ちゃんが小さめ、羊水も少ない**方だそうですが、赤ちゃんの心音は問題ないということでした。血圧を下げる薬を処方されました。入院して3日目に**胃のあたりが痛んで**つらく、少し吐き気もありました。看護師さんに胃が痛いと言ったところ血圧測定されずいぶん高くなっておりそのあとバタバタでした。血液検査もされ、しばらくしてから医師が来て血を止める**血小板が減っている**こと、**肝臓や腎臓の数値**も良くないので、このままだとお母さんも赤ちゃんも危険だということで緊急で帝王切開になりました。赤ちゃんは早産で、また小さかったのでNICUに入院しました。

手術室から病室に戻ってしばらくすると目がチカチカしてそのあとしばらく記憶がありません。**けいれん**を起こしていたそうです。けいれんは再発しやすいということで点滴の薬が追加されて降圧剤も追加されました。そのあと**脳のMRI**検査を受けましたが大きな問題はなかったそうです。退院するころには血圧も血液検査の数値も良くなり無事退院できました。

妊娠高血圧症候群

Hypertensive Disorder of Pregnancy
(HDP)

注：2017.8月 PIH→HDPへ改定！

HDPの定義



妊娠20週以降、分娩後12週までの間に高血圧が反復してみられる場合、またはこのような高血圧に蛋白尿や全身の臓器障害を伴う場合のいずれかで、かつ、これらの症状が単なる妊娠の偶発合併症によらないものをいう。

さらに、高血圧が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し、加重型妊娠高血圧腎症を発症していない場合を高血圧合併妊娠としてHDPに加える。

(日本産科婦人科学会JSOG 2017.8月)

病型分類



- ① 妊娠高血压腎症 PE (preeclampsia)
- ② 妊娠高血压 GH (gestational hypertension)
- ③ 加重型妊娠高血压腎症 SPE(superimposed preeclampsia)
- ④ 高血压合併妊娠 CH (chronic hypertension)



①妊娠高血圧腎症 PE (preeclampsia)

- 1) 妊娠20週以降に初めて高血圧を発症し、かつ蛋白尿を伴うもので
分娩
後12週までに正常に復する場合
- 2) 妊娠20週以降に初めて発症した高血圧に蛋白尿を認めなくても以下のいずれかを認める
場合で、分娩後12週までに正常に復する場合
 - ・基礎疾患のない肝腎機能障害
(肝酵素が基準値の2倍に上昇、他の腎疾患は否定)
 - ・脳卒中
 - ・神経学的障害(間代性痙攣・子癇・視野障害・頭痛など)
 - ・肺水腫
 - ・血小板減少(<10万/ μ l)
- 3) 妊娠20週以降にはじめて発症した高血圧に蛋白尿を認めなくても
子宮胎盤機能不全(胎児発育遅延、臍帯動脈血流波形異常、死産)を伴う場合

②妊娠高血圧 GH (gestational hypertension)

妊娠20週以降に初めて高血圧を発症し、かつ妊娠12週までに正常に復する場合で、かつ妊娠高血圧腎症の定義にあてはまらないもの。

③加重型妊娠高血圧腎症 SPE (superimposed preeclampsia)

- 1) 高血圧が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し、妊娠20週以降に蛋白尿、もしくは基礎疾患のない肝腎機能障害、脳卒中、脳卒中、神経学的障害（間代性痙攣・子癇・視野障害・頭痛など）、肺水腫、血小板減少（ <10 万/ μ l）のいずれかを伴う場合。
- 2) 高血圧と蛋白尿が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し、妊娠20週以降にいずれかまたは両症状が増悪する場合。
- 3) 蛋白尿のみ呈する腎疾患が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し、妊娠20週以降に高血圧が発症する場合。

④高血圧合併妊娠 CH (chronic hypertension)

高血圧が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し、加重型妊娠高血圧腎症を発症していない場合。

HDPにおける高血圧と蛋白尿の診断基準

- ①収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の場合を高血圧とする。
- ②次のいずれかに該当する場合を蛋白尿と診断する。
 - 1) 24時間尿で 300mg/日以上の蛋白尿が検出された場合。
 - 2) 随時尿でprotein/ creatinine比が0.27g/g・CRE以上である場合。
- ③ 24時間蓄尿や随時尿でのP/C比測定のいずれも実施できない場合には、2回以上の随時尿を用いたペーパーテストで2回以上連続して尿蛋白1＋以上陽性である場合を蛋白尿と診断する事を許容する。

症候による亜分類

①重症について

次のいずれかに該当するものを**重症**と規定する。

(軽症という用語はハイリスクでないと誤解されるため、原則用いない。)

1.妊娠高血圧・妊娠高血圧腎症・高血圧合併妊娠において、
収縮期血圧**160 mmHg**以上の場合
拡張期血圧**110 mmHg**以上の場合

2.妊娠高血圧腎症・加重型妊娠高血圧腎症において、
全身の臓器障害または**子宮胎盤機能不全**を認める場合

・蛋白尿の多寡による重症分類は行わない。

②発症時期による病型分類

妊娠**34週未満**に発症するものは、**早発型** (early onset type: EO)

妊娠**34週以降**に発症するものは、**遅発型** (late onset type: LO)

* わが国では妊娠**32週**で区別すべきとの意見があり、今後検討する予定である。

関連疾患



①子癇(eclampsia)

子癇は、妊娠20週以降に初めて痙攣発作を起こし、てんかんや二次性痙攣が否定されるものをいう。痙攣発作の起こった時期によって、妊娠子癇・分娩子癇・産褥子癇と称する。子癇は大腦皮質での可逆的な血管原性浮腫による痙攣発作と考えられているが、後頭葉や脳幹などにも浮腫を来とし、各種の中樞神経障害を呈することがある。

②HDPに関連する中枢神経障害

皮質盲、可逆性白質脳症(posterior reversible encephalopathysyndrome ; PRES), 高血圧に伴う脳出血および脳血管攣縮などが含まれる。

③HELLP症候群 (Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelets)

妊娠中・分娩時・産褥時に溶血所見(LDH高値)、肝機能障害(AST高値)、血小板数減少を同時に伴い、他の偶発合併症によるものではないものをいう。

いずれかの症候のみを認める場合は、HELLP 症候群とは記載しない。
なお、HELLP症候群に子癇や脳出血などの中枢神経障害を合併することがある。

HDP 母体要因



高齢妊婦、若年妊婦、肥満(BMI 30以上)、初産婦

合併症：腎疾患、慢性高血圧、血栓性素因、
糖尿病、甲状腺機能低下症、自己免疫疾患
体外受精

多胎妊娠、胞状奇胎

胎内発育遅延で出生した母体

既往妊娠：HDP、FGR、IUFD、早剥

HDPや心血管疾患の家族歴

HDPの病因と病態



Two Step Theory

第1段階
(1st trimester)

胎盤形成不全

分泌因子

第2段階
(2nd trimester以降)

母体血管内皮細胞障害

母体因子

免疫因子

HDP

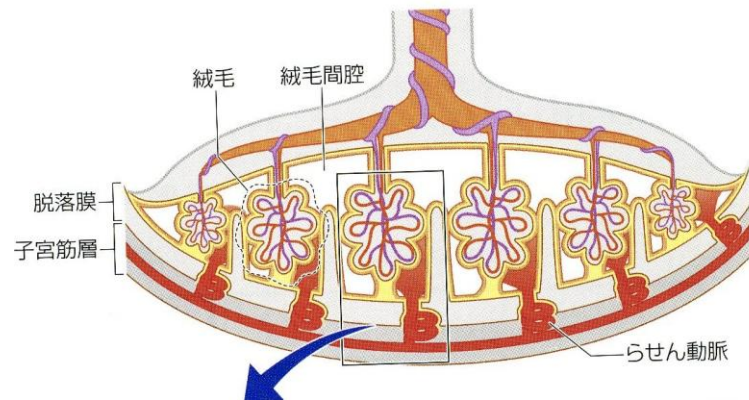
高血圧

蛋白尿

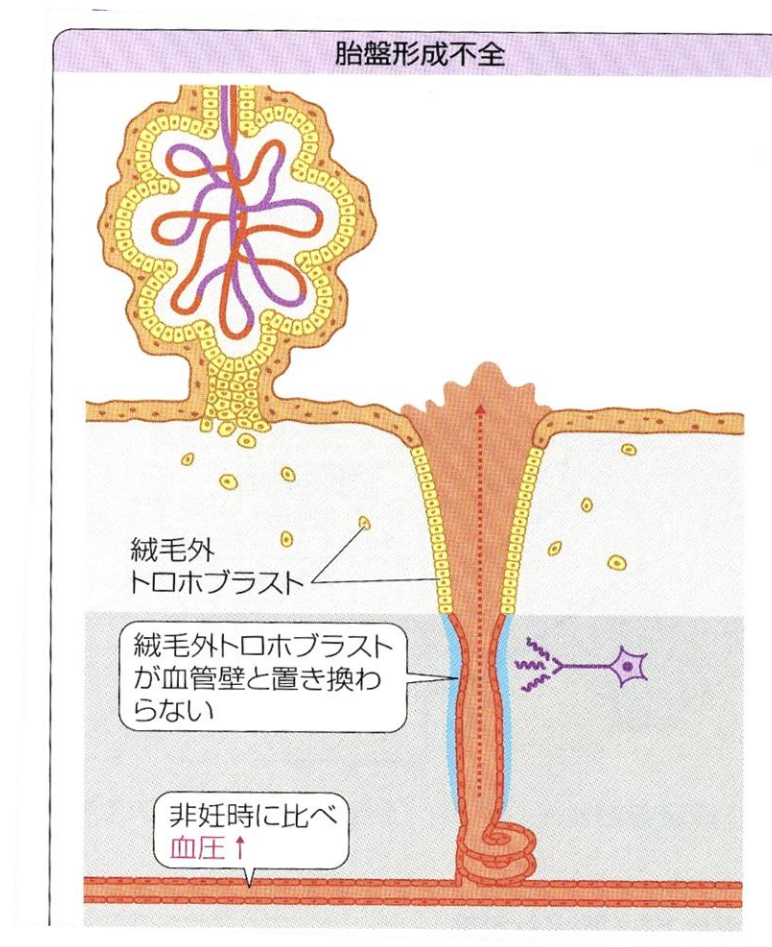
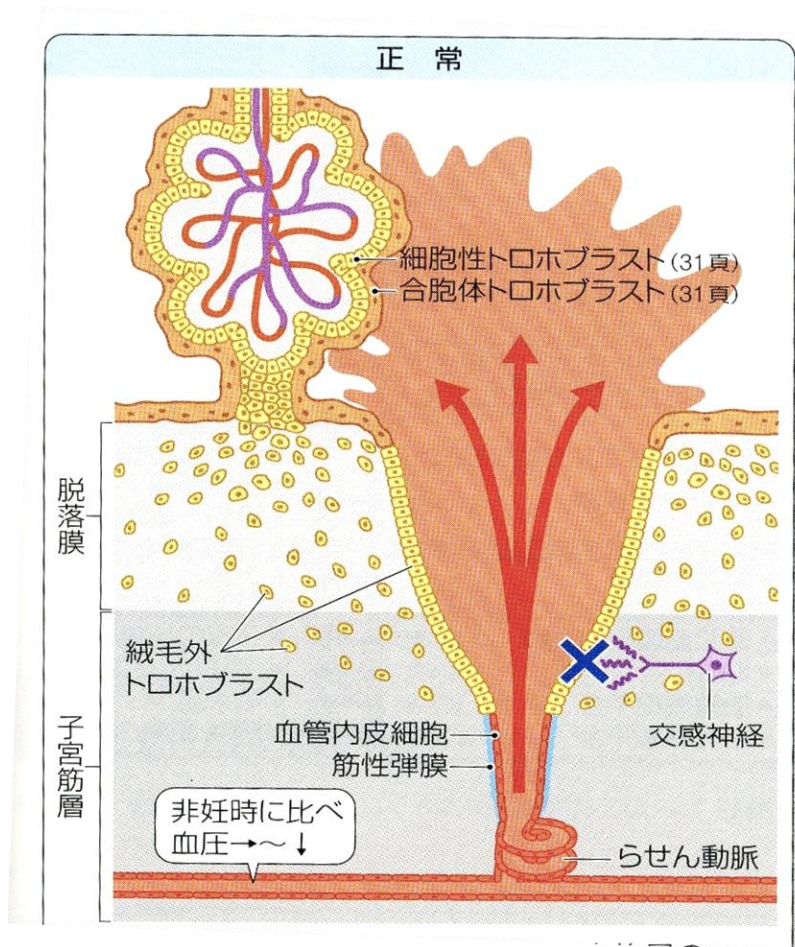
子癇

HELLPなど

正常



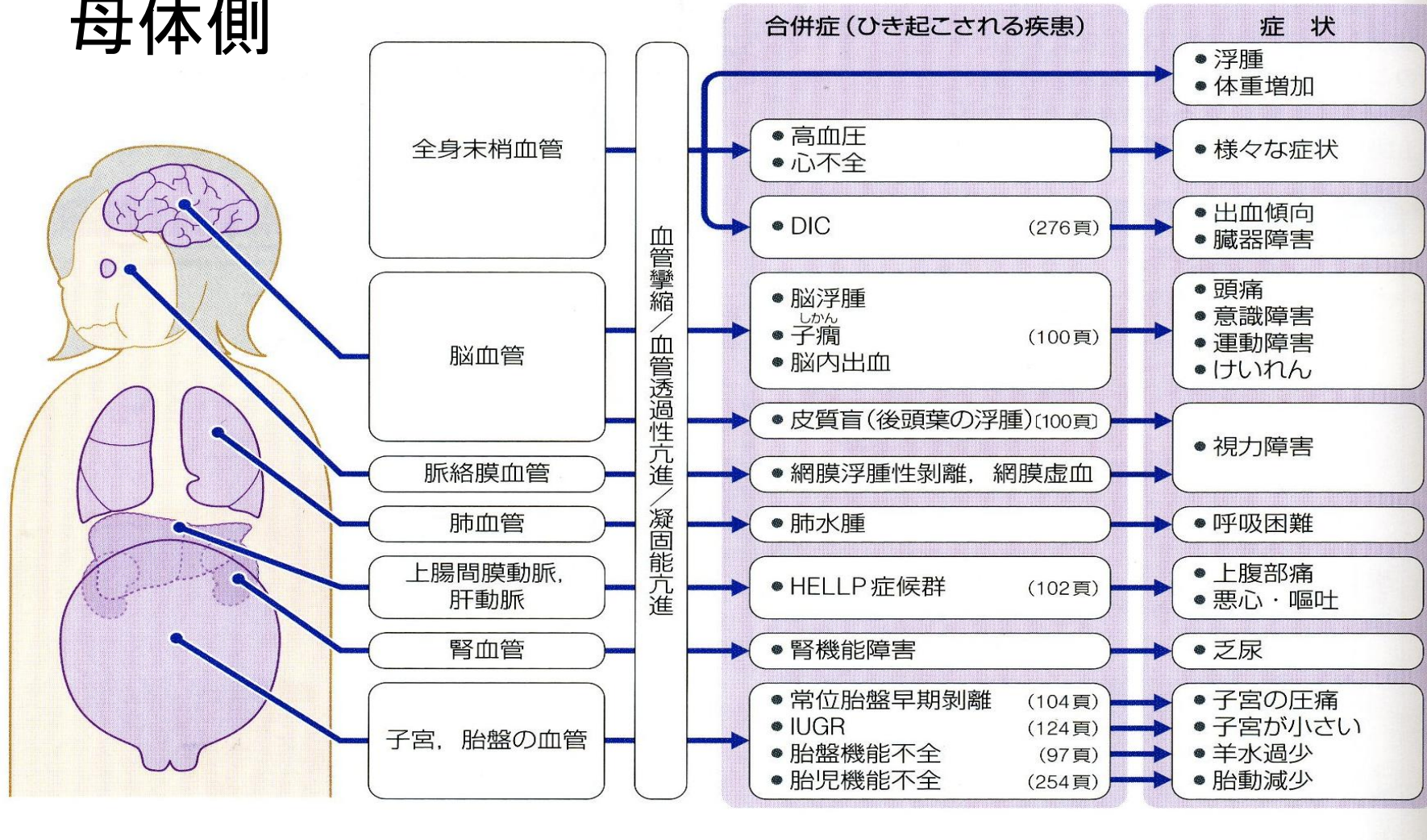
胎盤形成不全



HDP合併症と症状



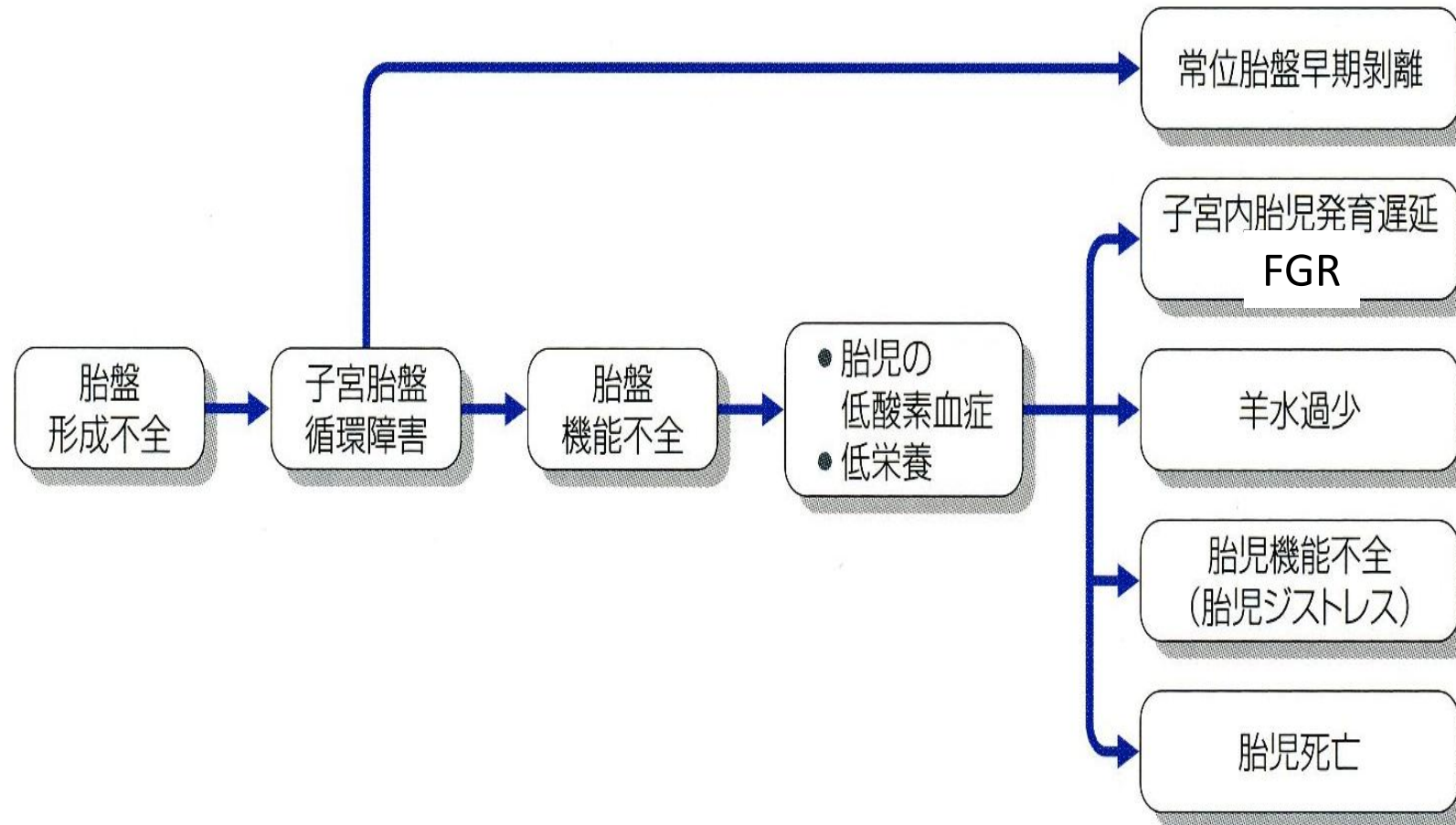
母体側



HDP合併症と症状



胎児・胎盤側



HDPの検査

母体検査

- 1.一般検査: 血圧 脈拍 CBC 胸部X線検査
- 2.腎機能: 尿量 尿蛋白定量 総蛋白 アルブミン 尿酸 Na K Cl
BUN Cre 尿中蛋白/クレアチニン比 24hCCr等
- 3.肝機能: GOT GPT LDH 総ビリルビン値
脂質代謝系 総コレステロール コレステロール分画 トリグリセリド
- 4.凝固線溶系 aPTT PT Fibrinogen FDP D-dimer AT-III TAT PIC等
- 5.眼底検査

胎児検査

- 1.胎児心拍モニター
- 2.超音波検査 胎児推定体重 羊水量(AFI) BPS (Biophysical
profiling score) 子宮胎児胎盤血流測定(臍帯動脈、中大脳動脈、
子宮動脈)

HDPの治療



- 入院管理 安静・(食事療法)
- 薬物療法:
 - 降圧剤 α 2刺激薬:メチルドパ、
 - $\alpha\beta$ 遮断薬:ラベタロール
 - Ca拮抗薬:ニフェジピン
- 子癇発作の予防:硫酸マグネシウム
- 妊娠の終了:分娩誘発や帝王切開術

最も効果的な治療

子癇の病態

脳血管障害と脳血液関門の破綻による

血管性脳浮腫

血管れん縮、脳虚血による細胞性脳浮腫

血管透過性亢進による循環血漿量減少や

血液濃縮および血液凝固亢進により脳虚血・
脳梗塞

HELLP症候群や脳虚血再還流による脳出血

MR Angiography

子癇



PIHにおいて妊娠20週以降から産褥期において初めてけいれん発作をおこし、
てんかんや二次性痙攣が否定されるもの

妊娠・分娩・産褥子癇がある

子癇のリスクファクター: 10代妊娠、初産婦、多胎妊娠、子癇既往、妊娠蛋白尿、HDP、HELLP症候群

RPLS: reversible posterior leukoencephalopathy syndrome

PRES: posterior reversible encephalopathy syndrome

→ **後頭葉**を中心とした皮質の可逆的な脳浮腫

頭痛、痙攣、嘔吐、視力障害、神経障害などの症状を呈する症候群

子癇と鑑別すべき疾患

CT、MRI、脳波検査などによる鑑別が有用

てんかん

脳血管障害(SAH、AVM、脳出血、脳動静脈血栓症、脳梗塞)

脳腫瘍 脳炎 髄膜炎

低血糖発作 過呼吸発作

羊水塞栓症

水中毒 褐色細胞腫 精神疾患(ヒステリー)

薬物中毒(局所麻酔剤など)

子癇の病態

脳血管障害と脳血液関門の破綻による

血管性脳浮腫

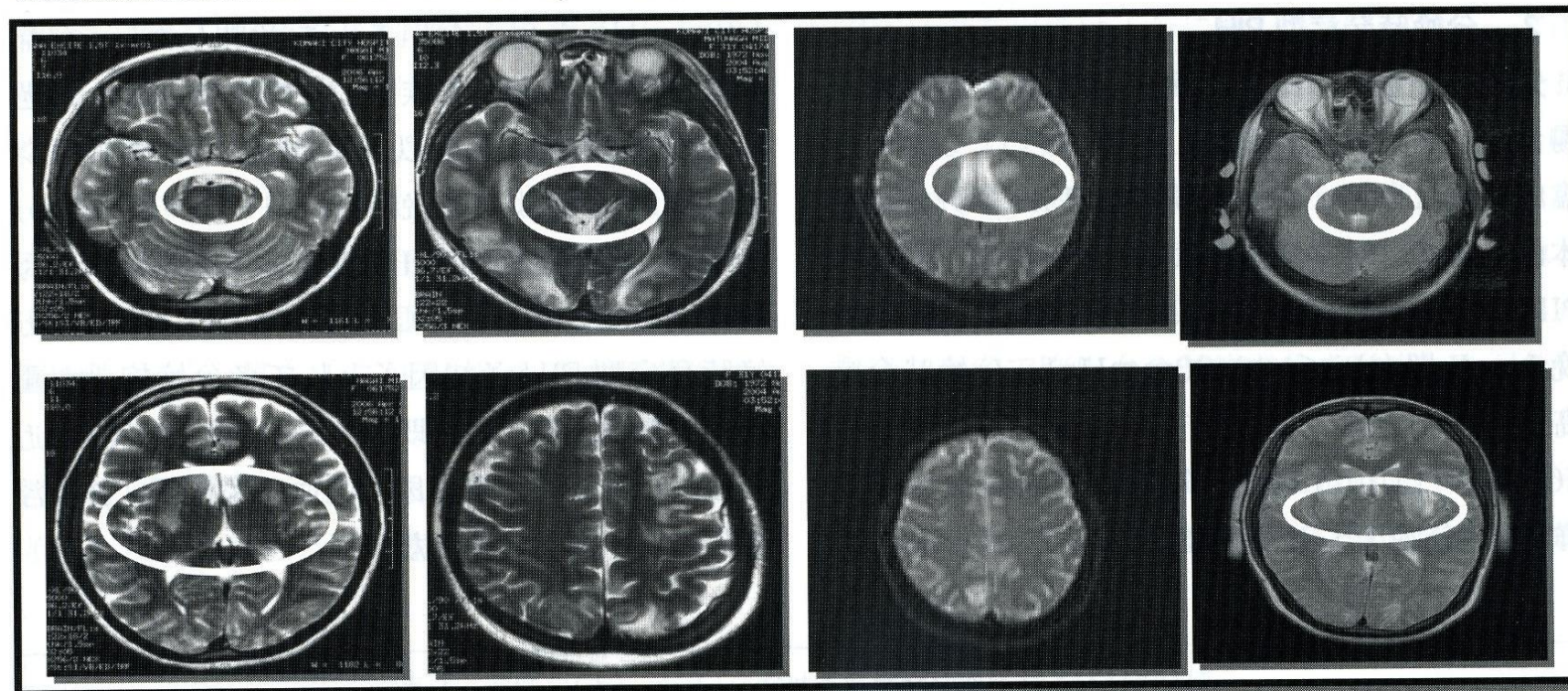
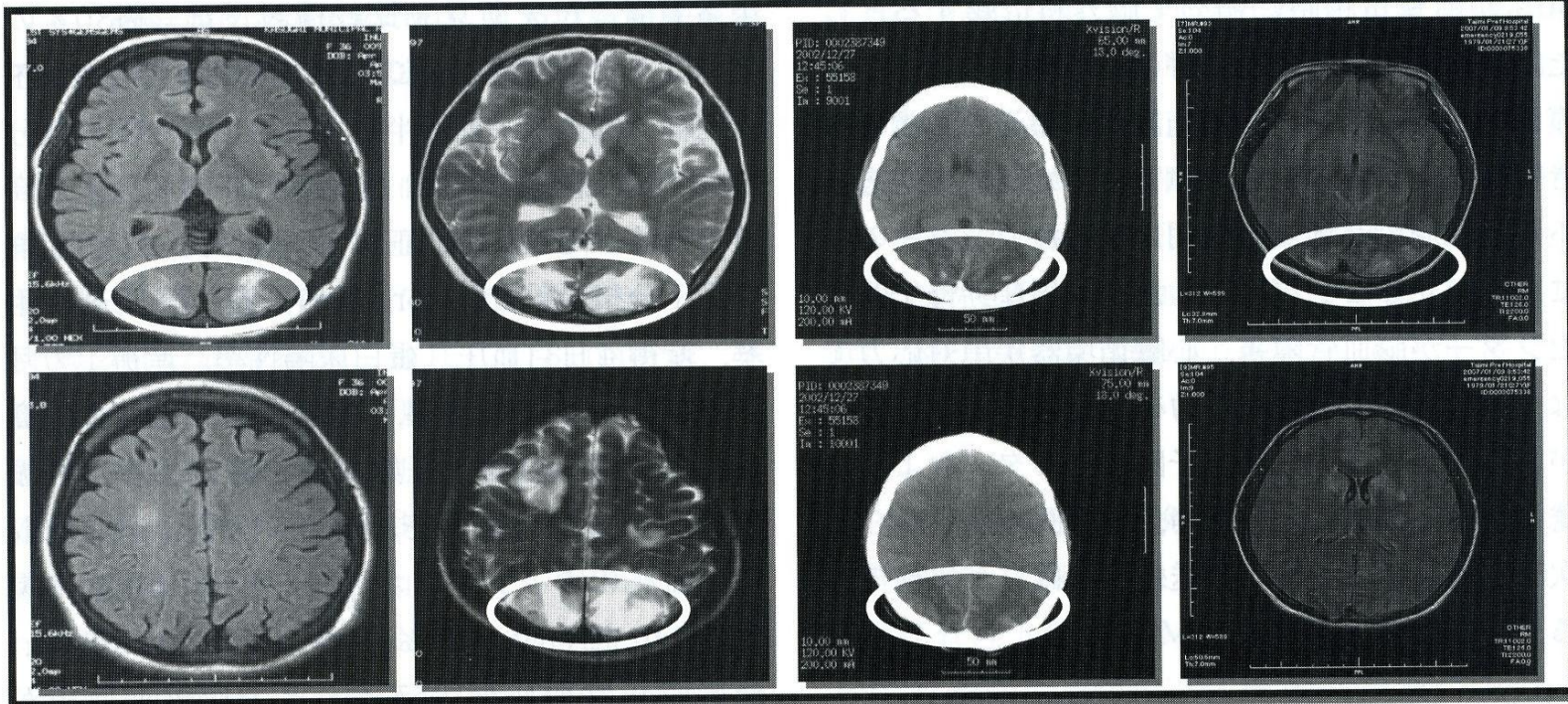
血管れん縮、脳虚血による細胞性脳浮腫

血管透過性亢進による循環血漿量減少や

血液濃縮および血液凝固亢進により脳虚血・
脳梗塞

HELLP症候群や脳虚血再還流による脳出血

MR Angiography

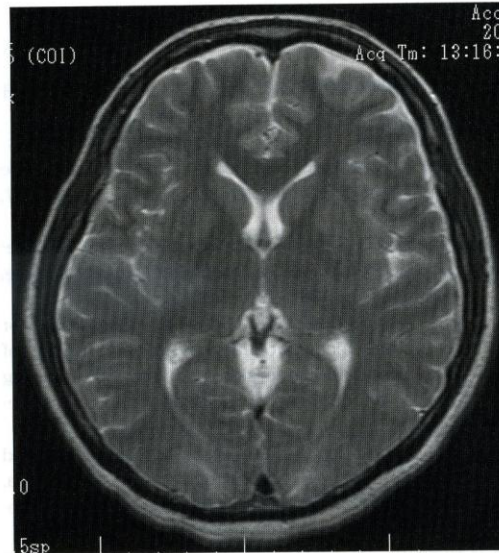


1



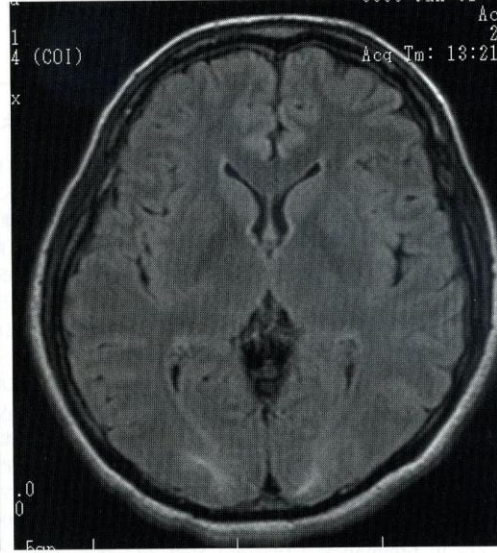
子癇発症当日のCT

2



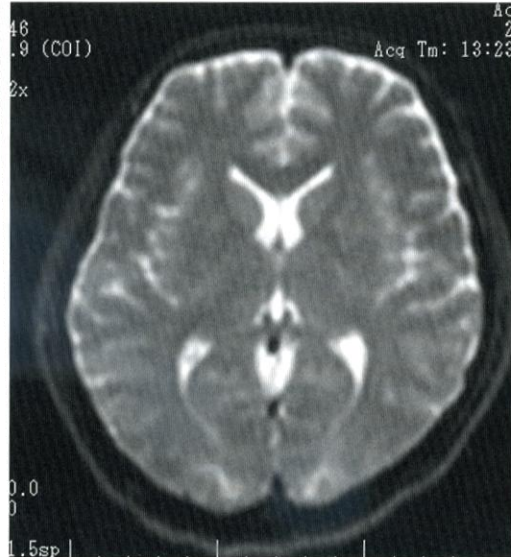
子癇発症翌日のMRI

3



後頭部に高信号域

4

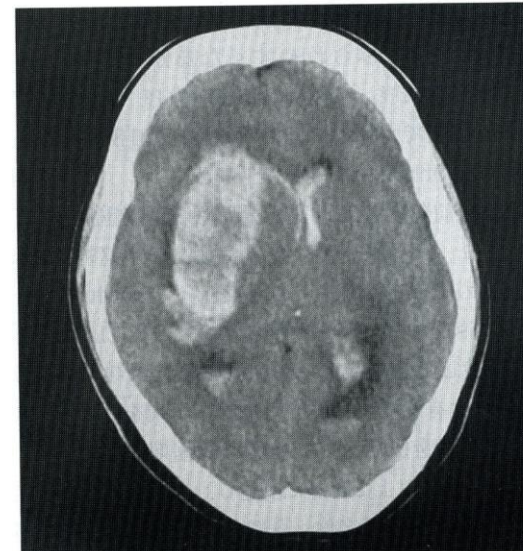


5



後頭部の血管原生浮腫

6



別の症例: 右被殻出血

子癇の治療

1. まず気道確保、酸素、誤嚥防止

2. 薬物投与

- ・ジアゼパム(抗けいれん剤)

- ・硫酸マグネシウム(子癇発作再発予防)

- ・降圧剤(高血圧持続の場合)

3. 安静(強い光と音を遮断←発症誘因となりうる)

* 妊娠子癇であれば児の娩出(通常は帝王切開)

HELLP症候群



Hemolysis (溶血)

Elevated Liver enzyme (肝酵素上昇)

Low Platelet (血小板減少)

重篤な合併症:

DIC、常位胎盤早期剥離、急性腎不全、肺水腫、被膜下肝血腫、
子癇、脳出血、母体死亡、
周産期児死亡

HELLP症候群の管理

- 1 HELLP症候群は**重篤な合併症**の発症率が高い
- 2 重症化、遷延化した場合急性妊娠脂肪肝、肝梗塞などの**他の肝疾患の可能性**を考える
- 3 一次施設でHELLP症候群(疑い)を発見した場合、高次施設への紹介が望ましい 「**HELLP**症候群は**HELP**が必要！」
- 4 診断がつき次第、**急速遂娩**
- 5 分娩後も自覚症状、バイタルサイン、採血データーに注意
- 6 **痙攣・意識障害**が発生した場合は頭部CT/MRIを行い脳出血など脳病変の発生がないかどうか調べる **脳出血発生の場合は母体死亡率高い**
- 7 HELLP症候群を疑った場合はDダイマーやATIIIなど**凝固系マーカー**に注意

症例 HDP

- 41歳1経妊0経産
- 既往歴：特になし
- 家族歴：父 高血圧
- 現病歴：体外受精で妊娠成立、近医で妊婦健診を定期受診。30週頃より血圧が上昇傾向(138/85mmHg)、32週より高血圧(145/92)、蛋白尿1+、33週で血圧155/98、尿蛋白2+となり、HDPと診断され、同日総合周産期センターへ紹介され、管理入院となった。

症例 HDP 続き

- 入院後経過: 入院時血圧165/98mmHg、尿蛋白定性3+、尿蛋白定量680mg/dL。頭重感と下肢浮腫の訴えあり。胎児発育は推定体重1580gでFGR、AFI 6cm、ノンストレステストreassuringであった。血液検査では明らかな異常値を認めず。高血圧に対してメチルドパ投与。
- 入院2日目(33週5日)、悪心と心窩部痛の訴えあり、血圧188/110mmHg、緊急血液検査で血小板7.5万/dL、AST 188、溶血所見があり、HELLP症候群の診断で全身麻酔下で緊急帝王切開施行。児は1502g男児Ap3/8、低出生体重児、早産児のためNICU管理。母体は病室へ帰室後、痙攣発作があり、子癇発作と診断しMg製剤、高血圧に対してCa拮抗剤投与。MRI検査では白質の異常所見は認めず。血小板数、肝酵素は術後5日目に正常値となり、血圧138/88mmHg、尿蛋白-となった。

胎児発育不全

Fetal Growth Restriction (FGR)

胎児発育不全(FGR): 胎児の発育の異常が生じて発育が抑制されるか停止し、妊娠期間に比べて異常に小さい状態をいう



診断: 妊娠週数毎の胎児推定体重の平均値-1.5SD未満で診断することが多い

* 妊娠週数が正しいことが前提

分類:

hypoplastic type (10~30%) 発育不全型

hypotrophic type (70~90%) 栄養不良型

体型的分類 symmetrical type
 asymmetrical type

表3-64 type 別 FGR の原因

胎児発育不全 fetal hypoplasia	胎児栄養失調 fetal malnutrition	原因不明
子宮内感染	多胎	
・風疹	胎盤・臍帯の異常	
・トキソプラズマ症	・胎盤機能不全	
・サイトメガロウイルス	・臍帯卵膜付着, 辺縁付着	
・水痘	・臍帯真結節	
・梅毒	・臍帯過長または過短	
染色体異常	・単一臍帯動脈	
・21 トリソミー	・周郭胎盤, 分葉胎盤	
・18 トリソミー	・胎盤血管腫	
・13 トリソミー	・胎盤のみの染色体異常 (mosaic) など	
・9q トリソミーモザイク	母体合併疾患	
・Turner 症候群 (45, XO)	・高血圧, 妊娠高血圧	
・cat crying 症候群など	・糖尿病, 妊娠糖尿病	
形態異常, 奇形症候群	・心疾患	
・種々の形態異常ことに多発性の場合	・喘息	
・骨形成不全症	・肺結核	
・軟骨異形成症	・甲状腺機能亢進症	
・Cornelia de Lange 症候群	・貧血	
・Russel-Silver 症候群	・膠原病	
・Hallermann-Streiff 症候群	・妊娠前のやせ, 妊娠中の栄養摂取不良	
・Potter 症候群など	・悪性腫瘍	
遺伝的な小柄	・高年妊娠, 若年妊娠など	
・母体低身長	母体薬物摂取	
	・喫煙	
	・代謝拮抗剤, 制癌剤	
	・麻薬 (ヘロイン) など	



CQ307-1 胎児発育不全 (FGR) のスクリーニングは？

Answer

1. 健診ごとに子宮底長を計測し、低値なら FGR を疑う. (B)
2. 妊婦全例に対して、妊娠中期以降 30 週頃までには超音波による胎児計測を行い、必要に応じて再検する. (B)
3. FGR の危険因子（表）を有する妊婦では、危険因子の除去または改善に努め、より慎重に胎児発育を評価する. (C)
4. FGR を疑った場合、妊娠初期計測値等を参考に妊娠週数を再確認する. (B)
5. 出生時体重基準曲線ではなく、胎児体重基準値を用い、 $-1.5SD$ 以下を FGR 診断の目安とする。胎児体重の経時的変化、胎児腹囲、および羊水量なども考慮して、FGR を総合的に診断する. (C)

（表 1） 胎児体重の妊娠週数ごとの基準値 ^{7) 8)}

gestational age	EFW (g)				
	-2.0SD	-1.5SD	mean	+1.5SD	+2.0SD
18W+0	126	141	187	232	247
19W+0	166	186	247	308	328
20W+0	211	236	313	390	416
21W+0	262	293	387	481	512
22W+0	320	357	469	580	617
23W+0	386	430	560	690	733
24W+0	461	511	660	809	859
25W+0	546	602	771	940	996
26W+0	639	702	892	1,081	1,144
27W+0	742	812	1,023	1,233	1,304
28W+0	853	930	1,163	1,396	1,474
29W+0	972	1,057	1,313	1,568	1,653
30W+0	1,098	1,191	1,470	1,749	1,842
31W+0	1,231	1,332	1,635	1,938	2,039
32W+0	1,368	1,477	1,805	2,133	2,243
33W+0	1,508	1,626	1,980	2,333	2,451
34W+0	1,650	1,776	2,156	2,536	2,663
35W+0	1,790	1,926	2,333	2,740	2,875
36W+0	1,927	2,072	2,507	2,942	3,086
37W+0	2,059	2,213	2,676	3,139	3,294
38W+0	2,181	2,345	2,838	3,330	3,494
39W+0	2,292	2,466	2,989	3,511	3,685
40W+0	2,388	2,572	3,125	3,678	3,862
41W+0	2,465	2,660	3,244	3,828	4,023

ざっくり平均の体重は
28wで1200g
30wで1500g
32wで1800g
後期は150~200g/w増

FGRの管理

**FGRリスク因子をもつ場合は発症前から注意して超音波検査
(リスク因子: 若年・高年妊娠、極端な偏食、喫煙、低体重、社会的経済的要因)**

原因を検索しながら発育経過を慎重に観察する

発症時期、体型的分類、HDPの有無、母体合併症の有無、胎児異常の有無、経胎盤感染など

**治療: 母体の安静(→子宮胎盤循環の増加)
喫煙があれば禁煙**

発育停止や胎児機能不全となれば娩出する



CQ307-2 胎児発育不全（FGR）の取り扱いは？

Answer

1. 以下の可能性を考慮して原因を検索する. (B)
 - 1) 母体因子 (CQ307-1 参照)
 - 2) 胎児因子 (形態異常や胎児感染) の精査
 - 3) 胎児付属物因子 (胎盤, 臍帯異常) の精査
2. 以下を示す場合には染色体異常も疑う (CQ106-1, 106-2, 106-3, 106-4, 106-5 参照). (C)
 - 1) 複数の形態異常
 - 2) 当該染色体異常に特徴的な形態
3. 管理中, 以下の検査のいずれかを必要に応じて行い, 分娩時期・様式を決定する. (B)
 - 1) NST (non-stress test), CST (contraction stress test), BPS (biophysical profile scoring)
 - 2) 超音波パルスドプラ法による胎児臍帯動脈血流測定など
 - 3) 超音波による胎児計測 (推定体重や頭部発育) と羊水量の推移
4. 分娩中は分娩監視装置による連続的モニタリングを行う. (B)

妊娠中の薬

妊娠中の薬→そもそも薬は「諸刃の剣」



薬剤の添付文書→妊婦については

「有益性が上回るときにのみ投与可能」

「妊婦への安全性が確立していないため、妊婦への投与は
避けること」
ほとんどの薬剤で書いてある

妊婦・授乳婦に薬剤を投与すると、その薬剤を必要としない胎児・乳児にも薬剤が投与される(程度は薬剤による)

流産→約15%

児の先天異常→3%程度

これらは原因がなくても起こりうる

多くの薬剤は妊婦・授乳婦に投与できるが、
メリット・デメリットと十分な説明が必要

胎児毒性

母体が摂取した薬剤が経胎盤的に胎児移行し、胎児に生じる有害作用を胎児毒性という。

- ①胎児に機能的異常を起こす
- ②胎児の発育を阻害する
- ③羊水過少症などを起こし、子宮内環境を悪化させる
- ④出生後の発育・発達に悪影響を及ぼす

胎児毒性を起こす主な薬剤



① NSAIDs (非ステロイド系抗炎症薬)

妊娠後期に使用すると、胎児の動脈管の早期閉鎖、出生後の肺高血圧や動脈管開存症の原因となる。羊水過少症も起こす

② 一部の降圧薬

母体の低血圧による胎盤循環血液量減少の影響と胎児毒性を考慮

ACE阻害薬、アンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB):

第2三半期以降に使用すると胎児の低血圧と腎血流の低下
→尿量減少→羊水過少症→肺低形成、四肢拘縮、頭蓋の変形

③ ワルファリン

初期の投与で胎児ワルファリン症候群

中期以降で母体・胎児療法の頭蓋内出血のリスクが増加

④ 向精神薬

出産に近い時期に使用すると傾眠、呼吸障害

母子保健

母子保健

母体保護法: 母体の生命健康を保護することを目的とした法律

母体保護法指定医

人工妊娠中絶、不妊手術

母子保健対策:

①妊産婦および乳幼児健診

1. 産婦健康診査

2. 1歳6か月検診、3歳児健康診査: 市町村に義務付けられている

②B型肝炎母子感染防止事業

③先天性代謝異常等検査: タンデムマス法

生後4日目頃の児の血液→先天性代謝異常症や先天性甲状腺機能低下症、
先天性副腎皮質過形成

④母子健康手帳

母子保健法により市町村が交付する手帳

妊娠届を提出すれば交付される

1942年から(当時は妊産婦手帳制度)発足

産科医療保障制度



医療事故への事後対応として、我が国が初めて「無過失補償：訴訟によらず、また医療提供者側の過失の有無にかかわらず、被害者が公平に補償を受けられる」考えを取り入れた画期的な制度

目的：分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、再発防止のための情報を提供することにより、紛争の防止、早期解決、産科医療の質の向上を図る

対象者：制度加入分娩機関の管理下における分娩により
「出生体重2000g以上かつ在胎週数33週以上」または
「在胎週数28週以上で分娩に際し、所定の要件に該当した状態」
で出生した児に、身体障害者障害程度等級1級または2級相当の重度脳性麻痺が発症し、運営機関が認定した場合

* 児の先天的要因（染色体異常など）、新生児期の要因（感染症等）、妊婦の故意や重大な過失、天災などによって発症した脳性麻痺や生後6か月以内に死亡したは除く

* 満1歳の誕生日から5歳の誕生日までに申請を依頼する

母子衛生統計



$$\text{合計特殊出生率} = \frac{\text{母の年齢別出生数}}{\text{年齢別女子人口}}$$

15歳～49歳までの1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に産む平均子供数
2を切ると人口は減少する

$$\text{妊産婦死亡率} = \frac{\text{妊産婦死亡数}}{\text{出産数(出生数+死産数)}} \times 100,000$$

$$\text{周産期死亡率} = \frac{\text{年間周産期死亡数*}}{\text{年間出生数}} \times 1000$$

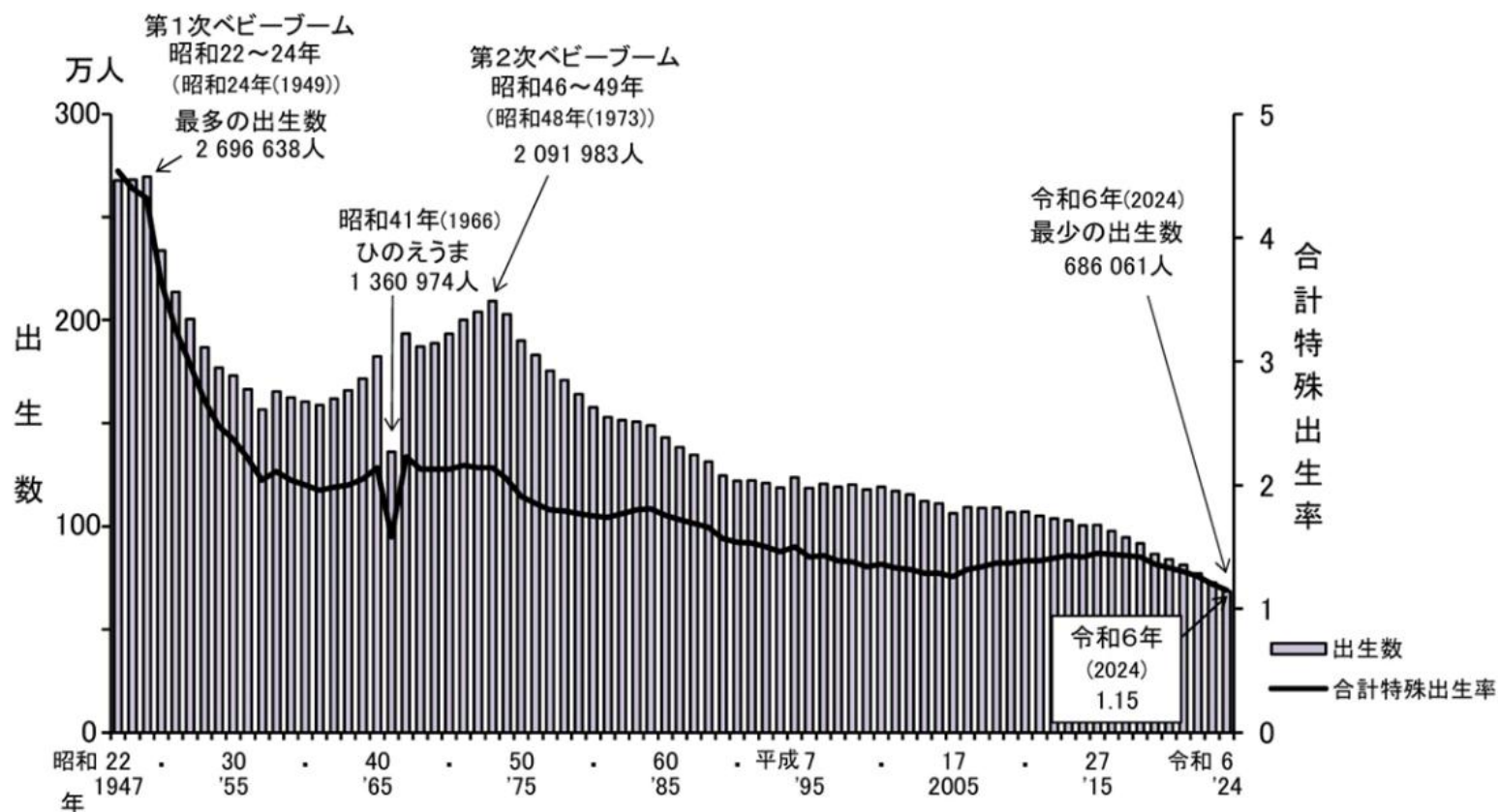
*妊娠22週以降の死産と早期新生児死亡をあわせたもの

出生数の未曾有の減少



2025年 出生 67.1万人 過去最少が10年連続

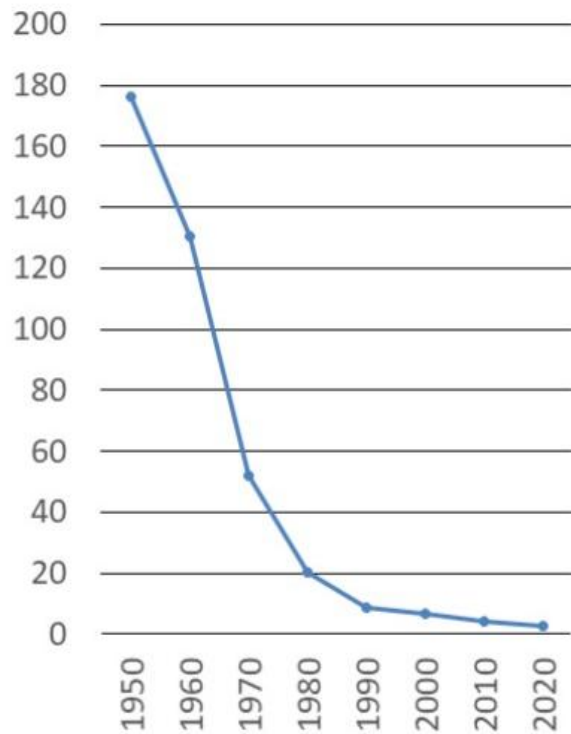
→2015年までは100万人前後であったが、
2019年(86.5万人)で初の90万人割れ
2022年に初の80万人割れ
2024年に初の70万人割れ



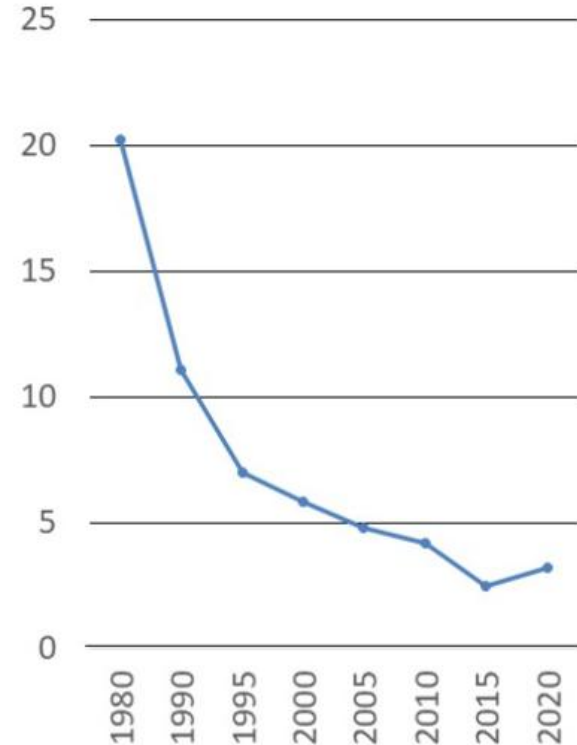


周産期死亡

妊産婦死亡率と周産期死亡率の年次推移



妊産婦死亡率(出産10万対)



周産期死亡率(出産1000対)

厚生労働省人口動態統計より

2024年

周産期死亡 2,285人

22週以降の死産数 1,800人

早期新生児死亡 485人

周産期死亡率 3.2(出生1000あたり)

→世界で最も低い

2023年

妊産婦死亡 32 概ね毎年25~30人前後

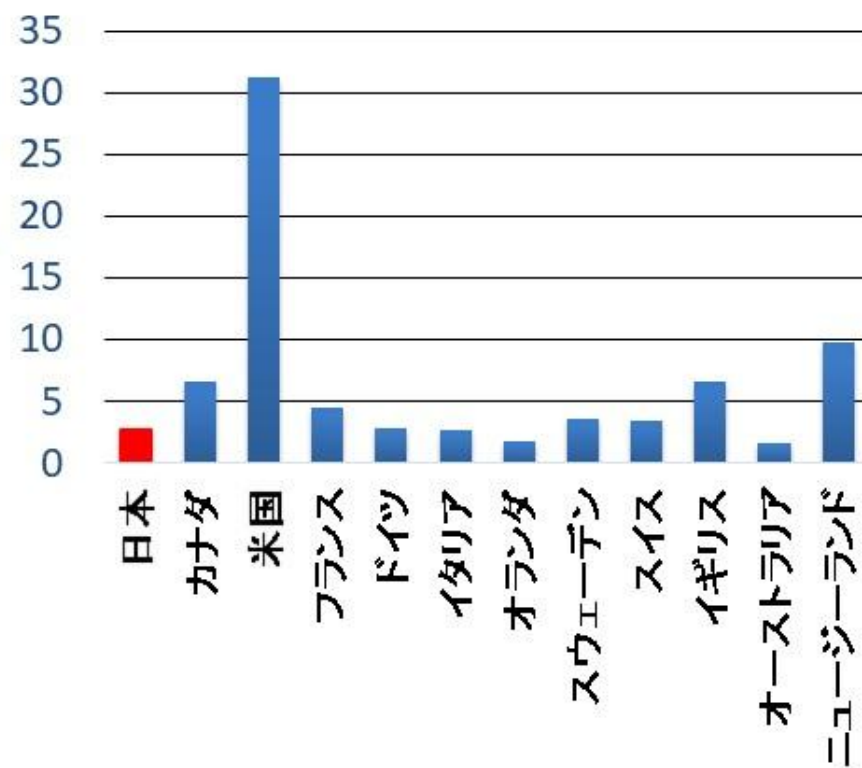
妊産婦死亡率(出生10万対) 3.2

世界の妊産婦死亡率は223(10万対)

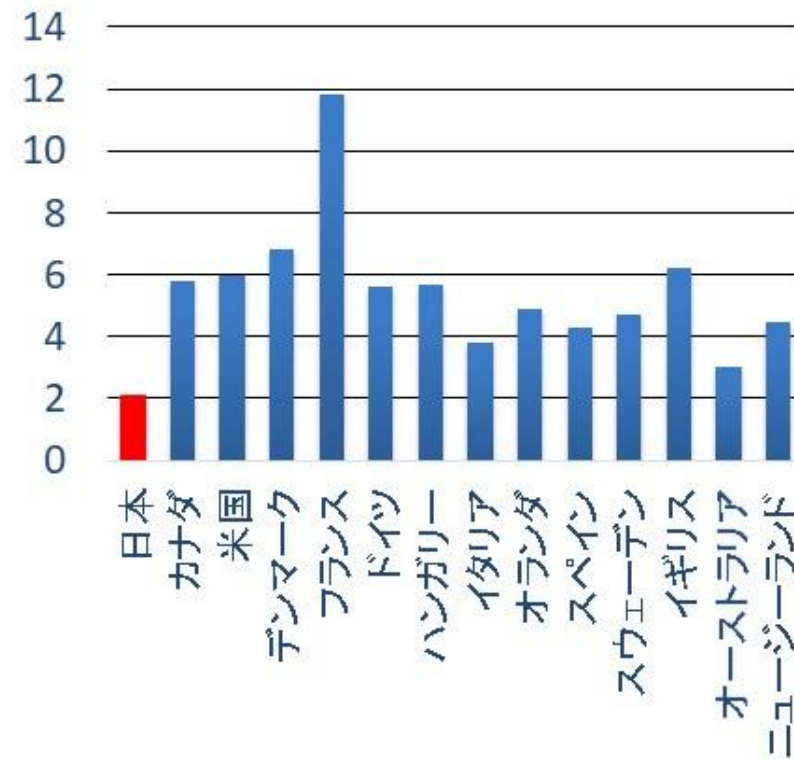
世界での妊産婦死亡率ワースト1:

南スーダン1150(2020年) 87人に1人死亡

妊産婦死亡率と周産期死亡率の国別比較（2019年）



妊産婦死亡率(出生10万対)



周産期死亡率(出生1000対)

2024年

合計特殊出生率 1.15 (この数年減少) 第一次ベビーブームは4超え
過去最低に

図1 出生数及び合計特殊出生率の年次推移

